

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ nadir期に合わせた電話フォロー(発熱・感染徴候)
- ☐ 手持ちの抗菌薬の服用開始条件と連絡方法の説明
- ☐ G-CSF後の骨痛への対応(体温を測ってから鎮痛薬)
- ☐ ST合剤・抗ウイルス薬など予防投与の継続確認
- ☐ 発熱・受診の経緯をトレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ レジメンのFNリスク評価とG-CSF一次予防の設定
- ☐ 投与前の血液検査で投与可否・減量を判断
- ☐ FN発症時の抗菌薬選択と院内対応
- ☐ 手持ちの抗菌薬の処方設計と説明
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

病院と共有する情報

レジメン・投与日

血液検査値

発熱・感染の有無

予防投与の服用状況

2 FNのリスク評価とG-CSF・抗菌薬の使い方

状況	対応の基本	薬剤師の確認ポイント
FN発症率20%以上のレジメン	G-CSFの一次予防を推奨	ペグフィルグラスチムは化学療法終了の翌日以降に投与(同日は避ける)
FN発症率10~20%のレジメン	リスク因子(65歳以上・全身状態不良・FNの既往等)で判断	リスク因子を薬歴に記録し、処方医と共有
前コースでFNを起こした	二次予防(G-CSF)または減量・延期	前回の発熱・入院の経緯を薬歴に記録
FN発症時:低リスク(MASCCスコア21点以上)	外来で経口抗菌薬(例:レボフロキサシン+アモキシシリン・クラバン酸)	手持ちの抗菌薬の服用開始の条件と連絡方法を説明
FN発症時:高リスク	入院のうえ広域の静注抗菌薬(例:セフェム等)	至急の受診を勧める

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意	メトトレキサート 葉酸代謝阻害の重複・排泄遅延	処方薬 ST合剤	骨髄抑制↑	他院のST合剤の処方を確認
注意	パルボシクリブ等 CYP3A4阻害	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬	血中濃度↑→好中球減少↑	他院の抗菌薬・抗真菌薬を確認
注意	FTD/TPI 吸収の増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝夕の食後に服用するよう指導
注意	ペグフィルグラスチム 骨髄前駆細胞の感受性↑	処置・検査 化学療法と同日の投与	骨髄抑制が増強するおそれ	化学療法の翌日以降の投与か確認
注意	レナリドミド 腎排泄の低下	既往・疾患 腎機能低下	血中濃度↑→骨髄抑制↑	CCrに応じた用量か確認
確認	化学療法中の・患者 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	FNの発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「治療後1~2週は、体を守る白血球が最も減る時期です。体温を毎日測る習慣をつけましょう」

確認:お薬手帳でレジメン・投与日、G-CSFの予定、手持ちの抗菌薬の有無

△ 夜間・休日の連絡先を事前に共有

投与後~1週

「生ものを控え、手洗い・うがいを。ペグフィルグラスチムの後は骨や腰が痛むことがあります」

確認:G-CSF後の骨痛と鎮痛薬の使い方、感染予防の実践

△ 痛み止めを飲む前に体温を測る習慣を

投与後1~2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」

確認:電話フォローで発熱・悪寒・のどの痛み・排尿時痛を確認

△ 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

次回来局時

「前回の治療のあと、熱や出血、息切れはありませんでしたか」

確認:検査値の推移、発熱・出血・貧血の症状

△ FNや減量の経緯はトレーシングレポートで共有